

10 - 02.2- Le cycle menstruel : SUA - Pr. Asmouki

(0:00 - 0:36)

Mon deuxième cours, c'était le cycle menstruel où il y a les saignements utérins anormaux qu'on avait déjà avancés dans ce cours-là. Maintenant, l'anglais est devenu incontournable. L'anglais scientifique n'est pas un anglais qui est très poussé, mais il faut lire beaucoup d'articles en anglais.

(0:39 - 1:14)

C'est devenu obligatoire dans beaucoup de domaines. Donc, ablat la maladie de l'inglésie, qui est un terme de la FIGO, la Figuration Internationale Génétique Austrique, c'est elle qui réagit à beaucoup de recommandations, notamment la terminologie, pour essayer d'unifier la terminologie des saignements, des saignements gynécologiques. Il y a des lacrymogènes, dont on a parlé un petit peu.

(1:18 - 1:59)

Les causes structurelles, c'est-à-dire organiques, polypathinoméose, l'ionium, tumeur maligne. Quand il y a un problème non structurel, problème de coagulopathie, problème endocrinien d'ovulation, problème endocrinien de l'endomètre ou des infections, ce n'est pas des problèmes organiques nécessitant souvent des traitements chirurgicaux. Bien sûr, les autres causes de saignements allurements, c'est-à-dire quand on parle de saignements allurements, les saignements génitaux, ce n'est pas comme les saignements utérins.

(2:00 - 2:23)

Les saignements utérins, c'est un saignement qui provient de l'utérus. Les saignements génitaux, c'est un peu plus général, c'est-à-dire les saignements d'origine vaginale ou vulvaire font partie des saignements génitaux, mais ne font pas partie des saignements utérins. Alors tout ce qui est saignement par le vagin peut être dû à un saignement non utérin, c'est-à-dire un saignement par le vagin.

(2:23 - 2:55)

C'est le tumeur vaginal, le vulvaire, les problèmes traumatiques et les problèmes de diaphragme qui peuvent parfois saigner. Je vous avais dit dans le plan, on va commencer par les idéologies avant de faire la démarche diagnostique, qui va être simplement déjà en parlant de beaucoup de choses. Alors, dans la démarche diagnostique, on commence toujours par l'histoire de la patiente, l'interrogatoire et l'examen physique.

(2:57 - 3:28)

Les principales choses, les principales peurs devant un saignement utérin anormal, je vous ai dit deux choses, la grossesse et le cancer. Donc ça revient ici. En fonction de la gravité du saignement, le saignement utérin anormal, parfois on peut déjà avoir un retentissement qui doit être d'abord pris en charge.

(3:28 - 3:42)

Il faut qu'un état immunodynamique soit correct. S'il y a des gestes d'urgence à faire, des voies veineuses, groppage, manque de sang, faire des hémostases, parfois il est pris. On se fait amener donc à la recherche étiologique.

(3:48 - 4:37)

Donc, l'histoire complète de la patiente, les intérêts des règles intérieures, l'âge de début des règles, l'aménagement, la diffusion, la date des dernières règles pour la grossesse, est-ce qu'il y a une notion de contraception, la quantité de saignement. Tout ça, c'est l'interrogatoire, c'est l'histoire de la maladie. La présence à l'examen, on verra à l'interrogatoire s'il y a une fièvre, s'il y a une fatigue, s'il y a une douleur de volonté, on peut la caractériser, des saignements parfois peuvent avoir un caractère familial d'une certaine maladie, de la coagulation.

(4:38 - 5:06)

La notion de prise médicamenteuse est très importante. Toujours en médecine, si vous avez un patient à plus forte raison en gynécologie, il faut demander est-ce que la femme prend un traitement. La contraception, les antivitamines K, les anticoagulants, les anticonvulsivants, la contraception, tout ça peut avoir des rencontres sur la paroi génitale.

(5:10 - 5:32)

Parfois, il y a des plantes médicinales qui sont incriminées dans des saignements, mais ce n'est pas prouvé. Il faut également demander est-ce qu'il y a des plantes médicinales qui diminuent les menstruations, qui peuvent entraîner des saignements, mais ce n'est pas prouvé par des études très sérieuses. Les études rendent en misère un homme aveugle.

(5:32 - 5:56)

S'il y avait une plante qui était incriminée dans une étude, on l'aurait, mais c'est toujours supposé. Il faut demander est-ce qu'il n'y en a pas. Par exemple, dans la grossesse, chez les femmes à la fin de la grossesse, il y a des médicaments qui peuvent entraîner un travail de contraception.

(5:57 - 6:20)

Il y a des choses que parfois, il faut ramener ces plantes-là. Bien sûr, en réanimation, dans certaines insuffisances rénales, on demande est-ce qu'il y a une notion de prise de plantes

médicinales qui peuvent avoir un effet sur la reine. Dans cette démarche diagnostique, l'examen gynécologique peut également déjà suggérer une météorologie.

(6:21 - 6:44)

Si on fait un spéculum, on voit un cancer du col. Bien sûr, le diagnostic, il est facile, il suffit de faire une biopsie pour confirmer ça. Donc, l'examen gynécologique est important, surtout l'examen gynécologique, le spéculum, le toucher vaginal combiné au palpé abdominal.

(6:44 - 7:03)

On peut apprécier la taille de l'utérus, voir est-ce qu'il n'y a pas de masse latérale utérine. Pour tout ça, c'est un élément important. On ne peut pas aborder un signe immunitaire anormal sans sauter l'étape de l'interrogatoire et de l'examen clinique.

(7:06 - 7:29)

Certains examens cliniques sont toujours obligatoires. Pour la hantise de la grossesse, toujours au moindre doute, demandez des pieds-à-sujets. Demandez un bilan, un hémoglobe pour rechercher s'il y a déjà un retentissement, surtout pour les éléments qui sont chroniques, et même pour les éléments qui ne sont pas chroniques mais qui sont abandonnés.

(7:31 - 7:45)

Alors, dans la part clinique, j'ai insisté la dernière fois sur l'échographie. L'échographie, c'est presque un prolongement de l'examen clinique. Tous les gynécologues ont des appareils d'échographie.

(7:45 - 8:01)

Ils doivent bien les utiliser pour rechercher. Un poumon peut le voir en échographie, un fibrome peut le voir en échographie, une hyperplasie de l'endomètre peut le voir en échographie. Donc, c'est un élément qui... La grossesse, bien sûr, l'échographie, beaucoup davantage.

(8:01 - 8:26)

C'est un examen simple qui est non-invasif, qu'on peut répéter le nombre de fois qu'on veut. Histérosonographie, ça c'est un peu moins connu. En plus de l'échographie simple, on injecte un liquide du sérum salé dans la cavité utérine, dans la cavité de l'endomètre, pour voir ce qu'il n'y a pas.

(8:26 - 9:01)

Parfois, on a un épaissement de l'endomètre, on ne sait pas si c'est juste une hyperplasie de l'endomètre, ou bien c'est un polype, ou bien c'est un fibrome, ou bien c'est un cancer. Parmi les

examens qui peuvent facilement nous aider, avant de faire des examens plus poussés, on injecte un peu de sérum salé pour dilater un petit peu cette cavité utérine, et on voit en échographie, de façon correcte, de quoi il s'agit, lorsqu'on a un endomètre qui est épicé ou irrégulier. Voilà un exemple d'échographie endovaginale.

(9:03 - 9:15)

Ça, c'est l'endomètre. Ça, c'est l'orifice sélisme avec l'orifice du col. L'intérieur, c'est l'endomètre.

(9:15 - 9:32)

Si on y met une mesure, on retrouverait qu'il est épicé. Vous voyez un schéma qui montre l'endomètre. La ligne de l'endomètre a un aspect différent en fonction, est-ce qu'on est en première partie du cycle, est-ce qu'on est en période ovulatoire, ou bien est-ce qu'on est en deuxième partie du cycle.

(9:32 - 9:53)

Donc on a des aspects échographiques de l'endomètre variables en fonction du cycle menstruel. S'il y a une anomalie, on peut la voir par cette échographie endovaginale. On voit un épaissement, on ne sait pas si c'est un polyp, ou bien s'il s'agit juste d'une hyperplasie de l'endomètre.

(9:53 - 10:22)

Lorsqu'on injecte du sérum salé à travers le col, vous voyez que le sérum salé dilate un petit peu cette cavité et il montre un aspect de polyp au niveau de la paroi postérieure de l'utérus. C'est cette histérosonographie. Dans cette recherche étiologique, il y a des infections, il y a des problèmes du col.

(10:22 - 10:54)

On va faire en fonction de l'orientation diagnostique, des prélèvements bactériologiques, côté cervico-vaginal, col poscopique, voire carrément biopsie du col, si jamais on trouve une anomalie à l'examen au spiculum au niveau du col. En fonction de l'orientation, l'interrogatoire et l'examen clinique sont obligatoires. À part la clinique, il y a des choses pour éviter la grossesse, le retentissement.

(10:55 - 11:09)

L'échographie fait partie intégrante, presque systématique, pour voir l'utérus. On voit bien l'utérus, on voit l'endomètre. On peut déjà avoir une grande aide par l'échographie.

(11:09 - 11:17)

Mais c'est en fonction du contexte. S'il y a une fièvre, on va faire une bactériologie. S'il y a des décorations pathologiques, on va faire une bactériologie.

(11:17 - 11:37)

Si le col est rouge, anormal, on peut faire un frotti, voire carrément, s'il y a une petite tumeur au niveau du col, faire de la biopsie. Toujours dans le bilan paraclinique, la biopsie de l'endomètre, c'est un élément très important. Il faut le mettre toujours, toujours.

(11:37 - 12:01)

C'est un élément hyper anormal. Quand je fais de l'échographie, je trouve cet aspect d'endomètre qui est épaissi, et que si jamais je ne fais pas l'hystérosomographie, dans ce cas-là, il faut explorer cette cavité. La meilleure façon de l'explorer, c'est d'aller la voir.

(12:02 - 12:18)

Comment on la voit, c'est l'hystéroscope, et on va la voir par la suite. Si on n'a pas d'hystéroscope, c'est pas comme l'échographie. L'échographie est présente chez tous les médecins, gynécologues et même généralistes.

(12:18 - 12:38)

Par contre l'hystéroscope, c'est un peu plus invasif, c'est beaucoup plus invasif. Il y a l'hystéroscopie diagnostique qui va utiliser des petites canules de moins de 5 mm. Il y a des gynécologues qui font de l'hystéroscopie en cabinet.

(12:39 - 13:14)

Mais c'est rare, rarement vous allez trouver un gynécologue qui va faire... parce que ça permet de voir la cavité, de voir l'origine du saignement, et éventuellement de faire des petites biopsies. Mais souvent l'hystéroscopie, elle est faite à l'hôpital, il faut une anesthésie générale, ou bien un rachis anesthésique pour aller dilater un petit peu le col pour introduire un optique plus grand. Et si on veut faire de l'interventionnel, il faut dilater le col parce que l'interventionnel, ça nécessite beaucoup d'instruments qui doivent avoir une cavité cervicale qui est plus grande.

(13:16 - 13:49)

Cette notion de biopsie de l'endomètre, elle est capitale pour voir le cancer du col, les cancers de l'endomètre, les anomalies de l'endomètre sont très fréquentes, il faut avoir une propre hystéologie. Donc il peut s'agir d'hyperplasies simples ou atypiques, il peut s'agir de cancers, parfois de séquelles d'endométrites qui peuvent continuer à saigner. Avant le développement de l'hystéroscopie, à un certain moment on faisait ce qu'on appelle des cure-tâches biopsiques de l'endomètre, CVE.

(13:49 - 14:21)

On continue à le faire lorsqu'on n'arrive pas à faire d'hystérocopie. Une cure-tâche biopsique de l'endomètre. Donc on a un endomètre qui est épicé, on a fait une échographie, l'endomètre apparaît anormal, c'est une femme qui est âgée, périninopose ou bien déjà ménoposée, on craint le cancer de l'endomètre, on a vu à l'échographie un aspect épicé de l'endomètre, peut-être qu'on n'a pas fait l'hystérocopie parce que peu de gynécologues la font, ça demande un petit peu un plateau, ça demande beaucoup de temps.

(14:23 - 14:44)

On peut faire un cure-tâche à la vente. On fait un cure-tâche de l'endomètre. Alors le cure-tâche c'est réputé chez les franquiens abondamment, ça permet un petit peu de faire la moustasse, et on va recueillir de l'endomètre qu'on va pouvoir analyser à la mapate.

(14:44 - 15:02)

Donc c'est ce qu'on faisait avant, on continue parfois à le faire, c'est ce qu'on appelle dilatation-cure-tâche. D'ici, en Anglais, c'est dilatation-cure-tâche. Peut-être utilisé par le chirurgien et l'endomètre, et l'enfant est élevé quand même, on a beaucoup de diagnostics positifs.

(15:04 - 15:32)

Lorsqu'on n'a pas un diagnostic positif, lorsqu'il est négatif, lorsqu'il est positif, lorsqu'il se dit qu'il y a un cancer de l'endomètre, on a le diagnostic. Mais lorsqu'il se dit que l'endomètre que je vois est hyperplasique, que ce n'est pas un cancer, il faut faire plus, il faut aller voir la clinique pour confirmer qu'il s'agit. Donc, il est sensible, il est spécifique, mais sa sensibilité n'est pas.

(15:32 - 15:47)

Il y a des fois négatifs. Ce que je veux dire, c'est que le cure-tâche à l'avenir, mais d'ici, dilatation-cure-tâche, on peut trouver le diagnostic dans beaucoup de cas, mais parfois on peut rater le diagnostic. Mais ça reste un moyen de biblioyage.

(15:48 - 16:08)

Le standard devant une anomalie de l'endomètre, le standard, c'est l'hystérocopie, voir la lésion et biopsier la lésion. Quand on voit une lésion, quand on ne voit rien, on dit qu'il n'y a rien, on ne voit que de l'endomètre. Quand on voit une lésion, la biopsie, il te dit polype, vous avez un diagnostic, vous pouvez être tranquille.

(16:09 - 16:32)

Par contre, si vous faites un cure-tâche de l'endomètre, sur un endomètre qui est épicé, il vous

dit qu'il est hyperplasique, vous ne pouvez pas être tranquille parce qu'il y a un faible pourcentage de sang à côté d'un cancer. La cavité, ça mesure 3-4 centimètres de largeur sur 3-4 centimètres de longueur. Elle est triangulaire, rappelez-vous, la cavité utérine.

(16:33 - 17:00)

Parfois, on peut rater une petite lésion, une grosse lésion, on ne va pas rater, mais une petite lésion, on risque de la rater. Donc, sur le DCI, c'est le diagnostic de l'endomètre, j'ai voulu le ramener parce qu'il y a des gens qui continuent à le faire. Épicissement de l'endomètre, j'ai une femme, après la ménopause, j'ai créé le cancer, je n'ai pas d'hystéroscope, je suis loin d'un CHU, d'une clinique qui a un hystéroscope.

(17:01 - 17:28)

Je fais un geste, je peux faire des fausses couches, j'ai une boîte de cure-tâche. Tous les hôpitaux périphériques ont des boîtes de cure-tâche parce que, si on peut dire que la plus grande fréquence des météorologies chez la femme, surtout en période active du génital, c'est le problème de la grossesse, c'est les fausses couches. Quand vous êtes de garde, vous allez voir 3, 4, 5 fausses couches par jour.

(17:29 - 17:42)

Le traitement de la fausse couche, il faut évacuer l'utérus. Tant que l'utérus contient des débris, il va continuer à saigner. La meilleure façon de faire rapidement l'hémostase, c'est de vider l'utérus.

(17:43 - 17:58)

Comme ça, on va lui permettre de se contracter et de faire son hémostase. Tous les hôpitaux périphériques ont des petites boîtes. Donc, si on a une femme qui est âgée et qui saigne, on n'a pas le moyen de confirmer rapidement, de l'envoyer.

(17:58 - 18:30)

On peut faire un petit cure-tâche glandomètre d'ici, et on peut, dans plus de 90% des cas, avoir un diagnostic exact. Dans la sensibilité, il y a des faux négatifs. Il y a différents types d'instruments, ça c'est au plastique, ça c'est au métal.

(18:31 - 18:40)

Tout ce que vous pouvez trouver, c'est cet instrument-là. Là, on en porte la sonde de karma. Il y a différents calibres.

(18:41 - 18:57)

En plastique, on peut la brancher avec un système d'aspiration. On l'introduit à l'intérieur du cône,

et on fait des mouvements de va-et-vient dans tous les bords de l'utérus. Ça permet d'aspirer du contenu de l'endomètre.

(18:57 - 19:18)

On peut avoir un diagnostic avec ça. On peut également, cette cannule-là, en métallique, on peut également la brancher avec soit une seringue, soit un système d'aspiration, et on peut faire des petits cure-tâches glandomètre. Sauf que ces cure-tâches-là, que ce soit avec le plastique ou le métal, ça ne fait rien d'autre.

(19:20 - 19:39)

Mais ça permet d'avoir du moment pour le diagnostic. Des questions ? La biopsie de l'endomètre, toujours y penser. Biopsie de l'endomètre, vous avez parlé de l'anémie, l'échographie, on cherche des anomalies.

(19:40 - 20:16)

L'endomètre, puisqu'il faut faire la biopsie de l'endomètre, on se pose toujours la question, est-ce que je dois faire la biopsie de l'endomètre ? Alors, quand je l'admets, on va avoir des indications de la biopsie de l'endomètre. Lorsqu'on a un signalement anormal, lorsqu'on a un endomètre à l'échographie qui est anormal, la biopsie de l'endomètre s'impose. Reste comment la faire ? Est-ce qu'il faut la faire à l'aveugle, par le DCI, dilatation-curtage ? Ou bien est-ce qu'il faut la faire avec l'hystéroscopie, voir la lésion et la biopsie ? Donc ça, c'est une fonction de moyens communs.

(20:16 - 20:47)

L'IMDIA, c'est l'hystéroscopie pour le diagnostic et pour la biopsie. Mais si on n'a pas, on peut faire des curtages biopsiques de l'endomètre avec la dilatation-curtage. Des questions ? Est-ce que je vois rien ? La biopsie de l'endomètre, avec ses... Oui ? Oui ? Donc, tout le temps également, cette dernière canine en plastique, il est très très froid.

(20:48 - 21:14)

Même si on a besoin de dilater le cône, on peut entrer à l'intérieur de la cavité pour voir, pour se pousser du petit embout qu'on va recueillir, que d'autres choses. Alors, en consultation, on a essentiellement cette pince de Novac. Lorsque la femme vient à la consultation, on a fait l'échographie et on a un endomètre qui est ici.

(21:15 - 21:30)

On pose une crène au casier de l'endomètre. On a deux situations, on a deux choix. Soit on veut faire l'hystéroscopie, le test de référence.

(21:32 - 21:57)

Alors, en pratique, il faut qu'il soit vu par l'anesthésiste, il faut qu'il soit programmé, il faut qu'il soit anesthésié, il faut avoir le matériel d'hystéroscope, dilater, entrer l'endoscope. Alors, ça demande beaucoup de temps. Il y a une façon plus facile d'aboutir au diagnostic dans presque 90% des cas, c'est de faire le curetage au cabinet, à la consultation.

(21:58 - 22:24)

Avec cette sonde de karma, qui doit être bien sûr toujours prête dans le cabinet, dans une boîte stérile, qu'on va brancher à une seringue de 10 ou 20 cc, on l'introduit à l'intérieur du tuyau et on fait des petites aspirations. Et on fait des petits mouvements devant le bien. Comme ça, on va recueillir du matériel, parce que l'endométrieque est ici, et qu'il peut nous donner le diagnostic dans 90% des cas.

(22:26 - 22:44)

Ça, ça permet de perdre vraiment beaucoup de temps. On a un diagnostic, dans ce cas-là, on va faire un bloc d'extension et une réunion de consultation pluridisciplinaire afin de planifier la stratégie thérapeutique. Mais sinon, si vous le renvoyez pour l'hystéroscopie, vous allez perdre beaucoup de temps.

(22:44 - 23:03)

Si vous avez l'hystéroscope au cabinet, c'est pas mieux. Si vous l'envoyez voir l'anesthésiste, la programmée pour l'hystéroscopie, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, l'hystéroscopie 3 croix, c'est le standard, c'est le bon standard, si on n'a pas ça, on s'en fout.

(23:04 - 23:15)

Ces instruments-là, on les fait lorsqu'on fait à l'avion. Alors pour l'hystéroscopie, c'est des appareils spéciaux, on l'envoie et on a des anses. Comme l'hystéroscopie, on a des anses pour réséquer.

(23:16 - 23:42)

Réséquer une partie qui est anormale pour l'étudier. Alors, on a vu le diagnostic, on a vu l'histoire, la clinique, les examens par la clinique. Alors les anomalies, on a déjà parlé des anomalies de l'endomètre qui peuvent être soit une hyperplasie, soit une lésion intra-épithéliale, un cancer in situ de l'endomètre.

(23:42 - 24:03)

Alors, métaplasie, c'est une transformation. Le terme métaplasie, en tant que médecin, il y a

beaucoup de gens qui, lorsqu'ils voient dans l'anapathie métaplasie, ils ont peur. Alors, ça n'a pas le même message, ça n'a pas la même signification que dysplasie.

(24:04 - 24:11)

Métaplasie, ça change, on change. Un endomètre qui est anglandulaire, il ne vient pas lui monter. Mais c'est normal, il n'y a pas d'anomalie nucléaire.

(24:11 - 24:22)

Par contre, une dysplasie, il y a des anomalies nucléaires. Une dysplasie précède le cancer. Donc, métaplasie, il n'y a pas peur.

(24:23 - 24:40)

Souvent, l'endomètre, lorsqu'il guérit, il peut guérir sous forme d'une métaplasie. L'endomètre, il y a de l'épithélium paviment à côté, il vient le couvrir, on parle de métaplasie. Métaplasie, c'est un changement de type d'épithélium.

(24:41 - 24:49)

Mais ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une lésion précancéreuse. La lésion précancéreuse, c'est la dysplasie. Dysplasie, c'est des anomalies nucléaires.

(24:49 - 24:59)

C'est là où il faut s'alarmer. Ça, c'est un message important. On voit ici l'échographie qui montre un endomètre qui est épicé.

(25:01 - 25:14)

Alors, on pouvait faire l'hystérogaphie comme dans le cas qu'on a vu tout à l'heure. Il va montrer le polype de façon correcte. Là, on a ce milieu, c'est l'hystéroscopie.

(25:14 - 25:28)

Vous voyez que ça, c'est du sérum salé ou bien un autre produit qui permet un petit peu de dilater cette cavité-là. Ça, c'est une cavité de l'endomètre. Ça, c'est le myomètre.

(25:28 - 25:36)

Ça, c'est l'utérus, le myomètre. Là, c'est le myomètre, l'endomètre. Il y a une structure à l'intérieur.

(25:37 - 25:49)

Lorsqu'on fait de l'hystéroscopie, on voit les liquides qui entourent ce polype-là. Ça, c'est un polype. C'est un polype de l'endomètre.

(25:49 - 26:01)

Et si on passe par le coin, le premier à accéder à le polype, le PC de polype. Alors, il suffit de résister ce polype-là avec des onces. Ça, c'est après résiction.

(26:02 - 26:11)

Ça, c'est une vue hystéroscopique. Après résiction, vous voyez que ce polype-là, vous voyez qu'il y a un peu de sang qui l'entoure. Je ne sais pas si vous voyez bien dans l'image.

(26:15 - 26:33)

Moi, je vois bien au PC. Donc, on voit le polype, grosso modo, avec des structures, avec quelques milliers de sang en bas qui l'entoure. L'image à la fin, c'est après résiction, avec un réseptoscope, le problème de l'hémorragie va être réglé.

(26:37 - 27:13)

Donc, cette image-là, je ne sais pas ce que je l'ai après, c'est le résumé d'une tablée de palmocoïn que l'on a vue tout à l'heure, avec les causes structurelles et les causes non-structurelles. Là, c'est palmocoïn, causes structurelles, causes non-structurelles. On voit même les images, le polype diatrogénique, c'est-à-dire un problème soit de traitement, ou bien de stérilité.

(27:13 - 27:19)

Ça, c'est un stérilité. Problème ovarien. Problème de colonie compagnie.

(27:20 - 27:35)

Ça, c'est un endomètre qui a un endomètre. Vous voyez bien ? Vous voyez ? Là, c'est l'endomètre et il s'épanouit. Le fibrome, c'est la même chose.

(27:35 - 27:55)

Dans ce cas-là, il ne va pas perséminer, mais lorsqu'il s'approche de la cavité, lorsqu'il est à l'intérieur de la cavité, parfois il se développe à l'intérieur de la cavité, c'est là où il est coupable du sénement. Donc, le fibrome intracavitaire comprend également le fibrome soumiqueux. Soumiqueux, c'est-à-dire à l'intérieur de la cavité.

(27:57 - 28:04)

Soumigueux, mais à l'intérieur de la cavité. Ou bien intracavitaire apparemment, c'est à l'intérieur de la cavité. Soumigueux et intracavitaire, c'est presque la même chose.

(28:05 - 28:18)

C'est que la masse, elle est dans la cavité. Et quand la masse, elle est dans la cavité, elle va être à l'origine du sénement. Il ne faut pas qu'on l'enlève pour arrêter le sénement.

(28:18 - 28:29)

Il n'y a pas de traitement médical. Lorsqu'on a un polype, ou bien lorsqu'on a un fibrome intracavitaire, ou bien soumigueux, il faut le réséquer. Il n'y a que l'autre chose.

(28:30 - 28:42)

À l'intérieur de la cavité, la forme va continuer à séner. Alors, c'est la même structure. Après, on a le fibrome.

(28:43 - 28:52)

Le fibrome, c'est l'information intérieure du sénement. Ici, c'est l'information intérieure du responsable du sénement. C'est exceptionnel.

(28:56 - 29:19)

Les sources exogènes, les traitements, les causes générales. Alors, les causes intérieures, que ce soit l'entraînement de la masse, ou l'hystérie, c'est ici l'entraînement. Les traitements hormonaux permettent d'entraîner le sénement.

(29:21 - 29:36)

Les traitements hormonaux, quand on donne des progestins, en forme d'œufs, ça va entraîner l'améliorer. Ça entraîne des sénements anormaux par l'atrophie de l'endomètre. Lorsque l'endomètre est hyperplasique, il sène.

(29:36 - 29:48)

Lorsqu'il est atrophique, il sène. Il ne doit pas être hyperplasique comme il ne doit pas être atrophique. Lorsqu'on donne des œufs, des progestins, ils sont très puissants.

(29:49 - 30:16)

Ils atrophiaient l'endomètre et ça peut être une cause de sénement. Sur les anticoagulants, tout ce qui est maladie générale va être entier. Ça va entraîner un problème d'annulation par perturbation de la commande hypothalamo-hypophysiaque.

(30:17 - 30:46)

Maladie générale, insuffisance rénale terminale, hépatique grave, dénutrition grave, cancer avancé, ça va perturber la commande centrale, l'axe hypothalamo-hypophysiaire, et ça va retentir sur le pic de FSH-LH, donc ça va retentir sur l'ovulation et ça va entraîner des échecs par annulation dû à un problème de dérèglement de la commande centrale. Donc tout ce qui est général, ça entraîne. Tout ça, vous direz, je reviens.

(30:47 - 31:12)

L'objectif du cycle menstruel, c'était quoi ? L'objectif du cycle menstruel, c'est quoi ? C'est d'avoir des grossesses. Lorsque le cycle menstruel est perturbé, l'organisme donne des signaux au cerveau de lui dire d'arrêter l'ovulation parce que je ne vais pas être capable d'avoir une grossesse, d'assurer une grossesse jusque. C'est un moyen de défense.

(31:15 - 31:44)

Bien sûr, dans ces causes générales, il y a une cause qui est relativement fréquente, c'est la maladie d'obésité qui se manifeste essentiellement chez les jeunes. Comme je dis, la maladie d'obésité, c'est une pathologie congénitale qui va être une véritable épreuve d'effort pour les moustaches. S'il arrive à faire en sorte que les moustaches avec les règles, c'est qu'il n'y a pas de pathologie des moustaches qui est congénitale.

(31:44 - 32:31)

C'est comme la circoncision sur l'enfant, c'est la cause de l'apparition de certaines anomalies de coagulation. S'il y a des anomalies de plaquettes, une thrombopénie auto-immune par exemple, ou bien dans le cadre de l'hémophilie, ça va entraîner, d'ici un moment, dans tous les organismes, en particulier au niveau de l'endomètre. Parmi les mesures variées, dans cette catégorie de non-structurale cause de maladie, un gros pourcentage d'annulation de ces moments utérins anormaux par rapport à l'annulation comme physiologique.

(32:31 - 32:49)

Je peux ajouter un gros pourcentage de ces moments utérins anormaux par rapport à l'annulation comme physiologique. On a expliqué quand il y a une annulation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cordon. Il n'y a pas d'annulation, ça veut dire qu'il n'y a pas de cordon.

(32:49 - 33:11)

S'il n'y a pas de cordon, c'est qu'il n'y a que des oestrogènes qui hypertrophient et hyperplasient l'endomètre. C'est l'hyperplasie qui permet d'arrêter cette hypertrophie et de rendre l'endomètre sécrétoire capable de capter l'oeuf. S'il n'y a pas de progestérone, s'il y a une annulation, s'il n'y a pas de progestérone, cette hyperplasie de l'endomètre à un certain moment va entraîner des

signes anormaux.

(33:12 - 33:24)

C'est la plupart des causes. Parmi les causes, c'est les maladies générales qui vont dire au cerveau de ne pas entraîner des pics. Il y a notamment le pic de LH qui est responsable de l'ovulation.

(33:25 - 33:38)

Et s'il n'y a pas de pic de LH, il n'y a pas d'ovulation. Et la fin va s'éloigner par un problème. Un mal-entraîné ou un mal-entraîné ne peut pas avoir les cordes séparées ou les cordes ouvertes.

(33:38 - 33:50)

Les cordes sont variées. Quelle soit la raison, si l'ovulation ne se produit pas, pour que le polystérone ne produise pas. Et l'endomètre prolifératif persiste.

(33:50 - 34:07)

C'est là où il y a le danger. L'endomètre prolifératif qui n'existait que lors de la première étape du cycle. Lorsqu'il devient persistant, c'est là où les anomalies de ces mouvements anormaux se produisent.

(34:11 - 34:38)

Pour cette raison, l'autre chose également, c'est que une femme qui est sous l'oxygène pendant une longue période les cancers sont dus à l'oestrogène. Le cancer de beaucoup d'organes, notamment le sein et l'endomètre. C'est l'hyperostrogénie qui va être un facteur équilibré dans la promotion, dans le départ du cancer.

(34:39 - 34:54)

Donc, dans ces situations-là, il n'y a que l'oestrogène qui ne peut pas être balancé par le polystérone. C'est là où va entrer l'hyperplasie de l'endomètre. De l'hyperplasie intra-épithéliale de l'endomètre, voire carrément de cancer d'endomètre.

(34:54 - 35:14)

Donc, c'est un facteur de risque. Lorsqu'il n'y a pas d'ovulation, lorsqu'il n'y a pas de corps jaune, lorsqu'il n'y a pas de progestérone, il n'y a que l'oestrogène, on dit que la femme a un climat oestrogénique prédominant. Avec le temps, ces oestrogènes-là, l'oestrogène, c'est désormais un anabolisant.

(35:15 - 35:21)

C'est déstabilisant. Ça entraîne la multiplication. Sur la multiplication, il est bien contrôlé.

(35:21 - 35:29)

Ça entraîne des choses qui sont normales. Mais parfois, lorsqu'il y a de la multiplication, ça se pérennise de l'autre. Parfois, il peut y avoir des anomalies au niveau du noyau.

(35:31 - 35:43)

Qui dit anomalies du noyau, c'est le cancer. Le cancer, c'est quoi ? C'est une anomalie du noyau. Une cellule, quelque part, devenue schizophrène, son noyau n'arrive plus à une anomalie.

(35:43 - 36:03)

C'est cette anomalie-là qui va favoriser le cancer. Bien sûr, il y a des phénomènes de réglage, mais parfois, l'une des petites cellules cancéreuses que l'organisme arrive à... Déjà, le noyau lui-même est capable de réparer les problèmes de l'ADN. Mais parfois, il est dépassé et c'est le départ du cancer.

(36:04 - 36:24)

Le cancer, le temps de départ, c'est une anomalie au niveau du noyau. Le climat oestrogénique, les oestrogènes, par le fait qu'ils entraînent une activité importante pour le métabolisme, pour l'anabolisme, peuvent parfois entraîner des cancers. Et la progestérone, heureusement, lorsque... Ça, c'est les études qui le montrent.

(36:24 - 36:51)

Lorsque la femme a une bonne... Lorsqu'elle a une bonne phase progestatif, elle fait moins de cancers, notamment au cancer de l'endomètre. Pourquoi il faut y trouver les oestrogènes et la progestérone ? C'est juste pour éviter, pour masquer, pour diminuer, pour atténuer l'effet des oestrogènes. Dans le traitement hormonal, on va avoir ça dans la ménopause, le traitement hormonal substitutif de la ménopause, on est obligé... L'oestrogène est capable d'enlever tous les signes de la ménopause.

(36:53 - 37:07)

Les bouffées de chaleur, les problèmes d'Alzheimer, les problèmes d'ostéoporose. L'oestrogène tout seul, il est capable de régler tous ces problèmes-là. Malheureusement, il a des bénéfices secondaires pour ces bénéfices secondaires-là, c'est le cancer d'endomètre et le cancer du sein.

(37:08 - 37:17)

Surtout, les deux cancers hormonaux dépendants en gynécologie, les deux cancers. Pas l'envers, l'envers, c'est épithélial. L'envers, ce n'est pas un cancer hormonaux dépendant.

(37:18 - 37:45)

Donc, les deux cancers qu'on a en gynécologie qui sont hormonaux dépendants, pas l'abîme, pas le cône, c'est l'endomètre et le sein. L'endomètre et le sein. Alors, finalement, le cône, si l'infection ne peut pas trouver le cône, c'est une maladie d'endomètre, une dysfonction de l'endomètre.

(37:45 - 38:01)

Je me suis dit que l'endomètre n'est pas grave. Parfois, les moustaches locales, ce n'est pas les moustaches générales, les moustaches locales sont des endomètres qui sont défaillantes. L'endomètre n'arrive pas à faire son moustache tout seul, on ne sait pas pourquoi.

(38:02 - 38:21)

C'est une cause qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui reste lorsqu'on fait tout le bilan. Il n'y a pas d'hyperplasie, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de sien, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de problème de moustache générale. Or, on tient une théorie qui dit que peut-être que les moustaches locales ne fonctionnent pas bien.

(38:22 - 38:39)

Dans ce cas-là, il faut donner des traitements empiriques. On traite à l'aveugle. Et le traitement qui va arrêter l'essayement radical, c'est quoi? C'est la chirurgie.

(38:39 - 38:52)

Quel type de chirurgie? C'est l'hystérectomie. Lorsque la femme a déjà des enfants et ne veut plus, l'utérus ne sert que pour les enfants. L'utérus, c'est pour les grossesses, pour les enfants.

(38:52 - 39:02)

Si la femme a déjà quatre enfants, cinq enfants et ne veut plus, il y a des simulateurs dont on n'arrive pas à expliquer la cause. On a fait tous les bilans. Elle continue à saigner.

(39:03 - 39:16)

On la laisse. Tous les traitements ne sont pas, les traitements musicaux n'arrivent pas à gérer la situation. Parfois, souvent, beaucoup d'indications d'hystérectomie sont faites dans ce cadre-là.

(39:17 - 39:32)

Beaucoup d'indications d'hystérectomie, c'est des hystérectomies de moustache. Et également, et également, et également, beaucoup de femmes demandent d'hystérectomie parce qu'elles ont peur de faire un cancer dans l'utérus. Il y a également la demande des femmes.

(39:33 - 39:45)

Lorsqu'elles saignent et n'arrivent pas à trouver la cause, il faut se mettre à la place de la femme. Par la cause, peut-être qu'il y a un cancer, il vaut mieux que j'enlève cet utérus-là. Parfois, ça a l'indication.

(39:46 - 40:03)

Donc, il y a des alternatives à l'hystérectomie. Il y a l'hystéroscopie et avec l'hystéroscope, il faut enlever même la couche basale de l'endomètre. Je vous avais dit qu'il y a une couche basale et une couche fonctionnelle.

(40:04 - 40:21)

La couche basale n'est jamais expulsée. Par les traitements qui permettent de diminuer un petit peu le risque de saignement, c'est la destruction de l'endomètre par hystéroscopie. On détruit l'endomètre, on crée des signes, on détruit cette cavité endométriale.

(40:22 - 40:31)

Ça peut marcher, ça peut régler le problème. Ça, c'est une méthode alternative à l'hystérectomie. Il y a beaucoup de méthodes.

(40:31 - 40:55)

Il y a des ballons et des cochons qui vont brûler l'endomètre. Il y a beaucoup de méthodes mais on les regroupe sous le terme destruction de l'endomètre et la chose la plus radicale c'est l'hystérectomie. L'hystérectomie peut être par voie abdominale, par voie vaginale, par stéréoscopie.

(40:55 - 41:16)

On peut le faire par différents types d'abord. Ces idéologies inconnues sont des diagnostics d'exclusion. A l'UDE, c'est un problème de dysrégulation de l'hémastase local de l'endomètre.

(41:17 - 41:51)

Les seuls cas de ces cas-là ce sont des dysrégulations de l'endomètre soit des dysrégulations de l'endomètre soit des dysrégulations qui se prolongeaient dans un diagnostic de hémostérobilité. On a différents types de profil de saignement lorsqu'on a des anomalies primaires de l'hémostase au niveau du glandomètre. Je rappelle toujours ce schéma-là qui fait le résumé.

(41:54 - 42:58)

Dans la conclusion, le cyclostimule, c'est un standard peine, c'est une introduction au saignement

utérin anormaux. Vous avez vu la première précision qu'on a pour uniformiser la technologie, la figure, l'écriture de la figure, en décrivant une technologie qui est éloignablement interférentielle pour tous les types de saignements, pour toutes les technologies qu'on avait auparavant, métrologie, ménorologie, hyperménorée, polyménorée, hyperpolyménorée, on a résumé tout ça en saignement utérin anormaux. Il faut faire la chronique pour les causes structurelles, pour les causes non structurelles, afin de parler le même langage, d'avoir le diagnostic, et quand on a le diagnostic, on peut faire le traitement étiologique le plus approprié possible.

(42:58 - 43:51)

Quand on parle de saignement utérin anormaux, salut tout le monde, il n'y a pas de questions, il y a 21 participants à distance. Est-ce qu'il y a des questions ? On va enchaîner toujours mon cours, il y a une grande partie, c'est de l'endocrinologie gynécologique, on est en train de parler de beaucoup de choses, c'est de l'endocrinologie gynécologique. On va parler des améliorés, même si vous avez fait une simbologie, pour moi, la simbologie que vous avez faite, ça fait déjà trois ans que vous avez fait ça, c'était une communauté avec beaucoup de spécialités, et donc je préfère répéter les choses, pour que ça soit mieux compris.

(43:54 - 43:59)

Donc on va enchaîner avec mon cours sur les simbologies.